Pathologies du tube digestif

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : RGO = reflux gastro-œsophagien · SIO = sphincter inférieur de l'œsophage · IPP = inhibiteur de la pompe à protons · Hp = *Helicobacter pylori* · AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens · MICI = maladies inflammatoires chroniques de l'intestin · RCH = rectocolite hémorragique · SII = syndrome de l'intestin irritable · FODMAP = glucides fermentescibles · SRO = soluté de réhydratation orale · AGCC = acides gras à chaîne courte · tTG = transglutaminase tissulaire · IDDSI = échelle des textures · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : 4 mécanismes de dénutrition = **apports ↓, malabsorption, pertes, hypercatabolisme** · RGO = **relaxations transitoires** du SIO · ulcère : **pas de régime**, pas de lait · Crohn = **tout le tube**, transmural · RCH = **rectum**, continu, muqueux · cœliaque = **auto-immune**, régime sans gluten **strict à vie**, jamais avant le diagnostic · lactose ≈ **12 g par prise** souvent toléré · fibres ≈ **30 g/j**.

1. Oralité et déglutition (32.3.1-2)

- Oralité **primaire** = réflexe (succion-déglutition-respiration coordonnées vers 32-34 SA) · oralité **secondaire** = volontaire (cuillère vers 4-6 mois, mastication vers 12-18 mois).
- **Néophobie normale** de 2 à 6 ans · troubles de l'oralité : causes organiques, sensorielles, traumatiques (sondes), psychiques · **ARFID** · prise en charge **sans forçage**, désensibilisation progressive, enrichissement.
- **Dysphagie oropharyngée** (transfert : AVC, Parkinson, âge ; toux, voix mouillée) ≠ **œsophagienne** (transport : obstacle → solides puis liquides ; trouble moteur comme l'achalasie).
- Pénétration (au-dessus des cordes vocales) ≠ **inhalation** (en dessous) → pneumopathie · risques aussi : déshydratation, dénutrition.
- Adaptations : posture **menton fléchi**, textures **IDDSI 0 à 7** (boissons 0-4, aliments 3-7 ; test de la seringue de 10 mL), épaississants, gastrostomie si besoin.

2. Œsophage et estomac (32.3.3)

- **RGO** : relaxations transitoires du SIO, hernie hiatale, pression abdominale ↑ · **pyrosis**, régurgitations · complications : œsophagite, sténose, **endobrachyœsophage (Barrett)** → risque d'adénocarcinome · pH-métrie (consensus de Lyon : 4-6 % = zone grise).
- Conseils RGO : perte de poids si surpoids, **tête du lit surélevée**, dîner **2-3 h avant le coucher**, repas moins copieux · IPP.
- **Hp** : gastrite chronique, ulcère, **cancer gastrique** (cancérogène certain), lymphome MALT · gastrite **auto-immune** du fundus → carence en **B12** (maladie de Biermer).
- **Ulcère** = perte de substance qui **franchit la musculaire muqueuse** (érosion = reste dans la muqueuse) · déséquilibre **agression** (acide, pepsine, Hp, AINS) > **défense** (mucus, bicarbonates, prostaglandines) · complications : hémorragie (hématémèse, méléna), perforation, sténose · diagnostic Hp : test respiratoire à l'urée marquée · **aucun régime**.

3. Intestin : MICI, SII, diverticules, cancers (32.3.3-4)

	Maladie de Crohn	RCH
Localisation	bouche → anus, surtout **iléon terminal**, discontinue	**rectum toujours**, extension continue au côlon
Atteinte	**transmurale**, granulomes, sténoses, fistules	**muqueuse**, rectorragies
Tabac	**aggrave**	« protecteur »

- MICI : terrain génétique (NOD2) + environnement + microbiote + barrière → inflammation (TNF-α) · suivi par la **calprotectine fécale** · dénutrition fréquente · protéines ↑ en poussée (1,2-1,5 g/kg/j) · **nutrition entérale exclusive** chez l'enfant (Crohn) · pas de régime sans fibres, **sauf sténose**.
- **SII** (critères de Rome IV : douleur liée à la défécation, à la fréquence ou à la forme des selles) · formes C, D, M · mécanismes : hypersensibilité, motricité, axe cerveau-intestin · **régime pauvre en FODMAP en 3 phases** (restriction 2-6 semaines → réintroduction → personnalisation), avec un diététicien · fibres solubles.
- **Diverticulose** (sigmoïde) → **diverticulite** (douleur fosse iliaque gauche, scanner ; antibiotiques non systématiques) · fibres ≈ 30 g/j, **graines autorisées**.
- **Cancers** : œsophage (épidermoïde : alcool + tabac ; adénocarcinome : RGO, Barrett, obésité) · estomac (Hp, sel) · **côlon-rectum** (adénome → cancer en ≈ 10 ans ; charcuterie, viande rouge ↑ ; fibres, calcium, activité ↓ ; test immunologique 50-74 ans tous les 2 ans).

4. Troubles du transit et microbiote (32.3.5-6)

- **Diarrhée** = ≥ 3 selles molles/j · aiguë < 2 sem, persistante, chronique > 4 sem · **osmotique** (cède au jeûne, trou osmotique élevé) ≠ **sécrétoire** (persiste au jeûne) · trou osmotique = $290 - 2 \times (Na^+ + K^+)$.
- Réhydratation par **SRO** (sodium + glucose : co-transport) · **réalimentation précoce** · le cola et les sodas ne conviennent pas.
- **Constipation** (Rome IV) : transit lent ou dyschésie · fibres, eau ≈ 1,5 L/j, activité physique · échelle de **Bristol 1 à 7** · signes d'alarme → coloscopie.
- **Microbiote** : autant de bactéries que de cellules humaines (≈ 1 pour 1) · rôles : AGCC (butyrate), barrière, immunité, vitamine K · **dysbiose** (antibiotiques, alimentation pauvre en fibres, IPP, césarienne) · *C. difficile* · pullulation du grêle (B12 ↓, folates ↑).
- **Probiotiques** = micro-organismes vivants bénéfiques · **prébiotiques** = substrats utilisés sélectivement par le microbiote · transplantation fécale (*C. difficile* récidivant).

5. Maladie cœliaque et déficit en lactase (32.3.7-8)

- **Maladie cœliaque** ≈ 1 % (souvent méconnue) · terrain **HLA-DQ2/DQ8** · gliadine modifiée par la tTG → réaction immunitaire → **atrophie villositaire** → carences (fer, folates, calcium) · diagnostic : **IgA anti-tTG + IgA totales**, biopsies · **ne pas commencer le régime avant** les examens · régime sans gluten **strict, à vie** (blé, seigle, orge) · ≠ allergie au blé (IgE).
- **Déficit en lactase** : primaire (majorité de la population mondiale), secondaire (transitoire), congénital (rare) · **maldigestion ≠ intolérance** (symptômes : diarrhée

osmotique, gaz) · test respiratoire à l'H_2 · ≈ 12 g de lactose par prise souvent tolérés · yaourts et fromages affinés · **garder le calcium** · ≠ allergie aux protéines du lait.

6. Chirurgies digestives (32.3.9)

- **Bariatrique** (IMC ≥ 40, ou ≥ 35 + comorbidité) : **sleeve** (ablation de la grande partie de l'estomac, ghréline ↓) · **bypass** (petite poche + court-circuit, GLP-1 ↑) · carences : **fer, B12, calcium, vitamine D, B1** → supplémentation **à vie** · protéines ≥ 60 g/j.
- **Dumping précoce** (10-30 min, osmotique) ≠ **tardif** (1-3 h, hypoglycémie) · fractionner, éviter sucres rapides, boire à distance des repas.
- Gastrectomie totale → **B12 injectable** · iléostomie : pertes d'eau et de sel → compenser.
- **Grêle court** (< 200 cm) : jéjunostomie → **limiter les boissons hypotoniques** (l'eau fait perdre du sodium), boire un SRO riche en sodium · côlon conservé : glucides complexes, limiter les oxalates.

Pièges

- Néophobie à 3 ans = **normale** · RGO = surtout **relaxations transitoires** (pas un SIO effondré).
- Érosion ≠ ulcère · le lait **ne soigne pas** l'ulcère (rebond acide).
- Crohn ne touche pas que le côlon · tabac **aggrave** Crohn.
- FODMAP = régime **temporaire** · diverticulose : graines et noix **autorisées**.
- Dépistage colorectal = **test immunologique**, coloscopie seulement s'il est positif ou si risque élevé.
- Diarrhée sécrétoire **persiste** au jeûne · cola = mauvais soluté.
- Cœliaque = auto-immune, pas allergie · hypolactasie : **ne pas supprimer** tous les laitages · sleeve = carences possibles.